

ITEM 353 : PANCREATITE AIGÜE

Pancréatite aiguë = inflammation aiguë du pancréas par activation intracellulaire ou intracanalair des pro-enzymes pancréatiques (trypsine...) : incidence = 15 000 cas/an en France (30/100 000 chez l'homme, 20/100 000 chez la femme)

Diagnostic	SF	- Douleur abdominale (90%) : épigastrique (parfois de l'hypochondre droit ou diffuse), volontiers transfixiante, violente, s'aggravant progressivement en quelques heures, irradie dans le dos et à l'épaule gauche, inhibe la respiration, position antalgique en chien de fusil (caractéristique), prolongée, résistante aux antalgiques - Vomissements (50%) : alimentaires puis bilieux - Iléus réflexe (occlusion fonctionnelle : 30%) : arrêt des matières et des gaz (rarement complet) et météorisme - Forme atténuée : douleur abdominale modérée et transitoire sans autres signes - Forme compliquée : choc, dyspnée, oligo-anurie, signes neurologiques, signes infectieux, hémorragie
	SC	- Météorisme, défense abdominale diffuse ou localisée à l'épigastre ou l'hypochondre droit - Rares : signe de Grey-Turner (infiltration hématique des flancs), signe de Cullen (ecchymoses péri-ombilicales)
	Bio	- Lipasémie > 3N : élévation précoce, parfois fugace, maximale à 24-48h, non liée à la gravité → L'association douleur typique + lipasémie > 3N pose le diagnostic de pancréatite aiguë → Une lipasémie < 3N n'élimine pas une pancréatite aiguë si réalisée > 48h après l'apparition des symptômes
	PC	→ En cas de certitude diagnostique, aucun examen d'imagerie n'est utile au diagnostic positif - Scanner d'emblée si doute diagnostique : perforation d'ulcère, appendicite, péritonite, diverticulite, occlusion... - Scanner injecté systématique dans les 72 à 96h après l'apparition des signes : évaluation de la gravité - Echographie abdominale systématique dès l'admission : diagnostic de lithias vésiculaire
	DD	= Douleur épigastrique brutale : ulcère perforé, infarctus mésentérique, péritonite biliaire, IDM inférieur, rupture d'anévrisme de l'aorte abdominale...
Complication	- Pancréatite bénigne oedémateuse (70-80%) → hospitalisation en service de médecine pour le bilan étiologique - Pancréatite sévère nécrosante (20-30%) → hospitalisation en USC voire USI : 20% de mortalité	
	SRIS	= Syndrome de réponse inflammatoire systémique : rare (15%) associée à une mortalité élevée (> 50%) - SDRA : hypoxémie isolée, détresse respiratoire, souvent associé à un épanchement pleural réactionnel - Défaillance cardio-vasculaire : choc - Insuffisance rénale oligo-anurique : d'origine fonctionnelle (75%) ou organique par NTA (25%)
	Sur-infection	= Surinfection de nécrose pancréatique par passage de bactéries digestives à travers la paroi intestinale : fréquente au cours des pancréatites nécrosantes (20-40%), jamais sur une pancréatite oedémateuse - 2 types : - Surinfection des coulées de nécrose non collectées - Abcès pancréatique par surinfection de pseudokyste → Cause principale de mortalité : responsable de 50 à 80% des décès
		Dg = Apparition tardive : 1 à 4 semaines après la pancréatite aiguë - Nouvelles défaillances viscérales, fièvre, syndrome inflammatoire biologique - TDM : bulles d'air dans les coulées de nécrose (rare, très évocatrice) en cas de germe anaérobie - Prélèvements bactériologiques multiples : hémoculture, ECBU, prélèvements bronchiques - Ponction de coulée de nécrose scannoguidée ou écho-guidée : confirmation
		TTT - Antibiothérapie IV à bonne diffusion : C3G, fluoroquinolone, imipénème, métronidazole ± Drainage endoscopique ou radiologique voire chirurgical (nécrosectomie)
	Autres atteintes digestives	- Ulcères multiples du 2^{ème} duodénum (± hémorragiques) - Hémorragie intra-péritonéale ou intra-kystique : due à une érosion artérielle par la nécrose - Fistule : - Interne : duodénale, gastrique, grêle, biliaire, colique, plèvre ou péritoine (épanchement) - Extériorisée à la peau - Thrombose splénique, mésentérique ou porte
	Autres	- CIVD - Encéphalopathie pancréatique (3-30%) : troubles confusionnels, désorientation temporo-spatiale - Syndrome du compartiment abdominal (par œdème viscéral, coulée de nécrose et iléus réflexe) - Cutanée (exceptionnelle) : tuméfactions sous cutanées, douloureuses, érythémateuses et diffuses → lésions de panniculites ± atteinte articulaire = cyto-stéato-nécrose systémique de Weber-Christian
	Pseudo-kyste	= Organisation et liquéfaction des foyers des nécroses : 5 à 10% des cas, tardive = en 5 jours à 6 semaines - Asymptomatique ou douleur abdominale - Diagnostic échographique ou TDM : lésion hypodense bien limitée - Evolution : disparition spontanée, infection, rupture, hémorragie, compression de voisinage

Score de gravité	- Terrain (FdR indépendant de gravité) : âge > 80 ans, obésité, insuffisance organique chronique → Les autres scores clinico-biologiques (score de Ranson, Imrie/Glasgow ou APACHE II en réa) ont été abandonnés					
	Score SIRS	= La persistante d'un SRIS au-delà de 48h prédit la survenue d'une défaillance viscérale et la mortalité - ≥ 2 critères: - Température > 38°C ou < 36°C - Fréquence respiratoire > 20/min ou PaCO ₂ < 32 mmHg - Fréquence cardiaque > 90/min - Leucocytose > 12 G/L ou < 4 G/L, formes immatures > 10%				
	CRP	= Marqueur biologique simple (non retenu) : pancréatite grave si CRP > 150 mg/L à 48h				
	Score de Balthazar	TDM abdominal injecté : réalisé systématiquement dans un délai de 72 à 96h après les 1 ^{er} signes cliniques - Coulées de nécrose extra-pancréatiques : non rehaussée au temps artériel - Nécrose pancréatique : absence de prise de contraste du parenchyme pancréatique au temps injecté - Complications : hémorragie, fistule, perforation d'organe creux → Score de gravité scannographique (CTSI) ≥ 4 : risque important de complication (abcès, décès...)				
		- Stade A : pancréas normal - Stade B : élargissement du pancréas - Stade C : infiltration de la graisse péri-pancréatique - Stade D : 1 coulée de nécrose - Stade E : ≥ 2 coulées de nécrose ou bulles dans une coulée ou le pancréas				+0 +1 +2 +3 +4
Nécrose pancréatique		- Pas de nécrose - Nécrose < tiers	+0 +2	- Nécrose < moitié - Nécrose > moitié	+4 +6	Score /10 0-3 : 8% pancréatite sévère, 3% mortalité 4-6 : 35% pancréatite sévère, 6% mortalité 7-10 : 92% pancréatite sévère, 12% mortalité
Étiologie	→ Dans 80% des cas : migration d'un calcul biliaire dans le cholédoque (40%) ou alcoolisme chronique prolongé (40%) - Bilan étiologique de 1 ^{ère} intention : échographie abdominale, bilan hépatique, calcémie, triglycéridémie					
	Origine biliaire	- FdR de lithiase biliaire : âge > 50 ans, femme, surcharge pondérale, multiparité, atcds familiaux - FdR de pancréatite biliaire : calculs de petite taille < 3 mm, nombreux ≥ 4, canal cystique large → Critères de Blamey : âge > 50 ans, femme, amylase > 13N, ALAT > 2-3N et > ASAT, PAL > 2-3N - Bio : - Pic d'hypertransaminasémie très précoce et transitoire : ALAT > 3N dans les 48h (VPP = 85%) - Hyperbilirubinémie : blocage du calcul dans l'ampoule de Vater - Echographie systématique dans les 48h (faux positif dû au jeun): recherche de lithiase vésiculaire - En l'absence de cause évidente si échographie normale : écho-endoscopie ou bili-IRM				
	Pancréatite alcoolique	= Poussée inaugurale de pancréatite chronique calcifiante dans > 90% des cas - Interrogatoire, contexte (homme, âge ≈ 40 ans), signe d'imprégnation alcoolique (VGM, GGT) → Pour retenir une cause alcoolique : alcoolisme prolongé > 10 ans et important > 10 verres/jour - Signes de pancréatites chroniques (calcifications, irrégularité des canaux) : souvent absent au début				
	Autres causes (20%)	- Tumeur pancréatique maligne ou bénigne - Post-opératoire ou post-CPRE (5%) - Hypertriglycéridémie > 10 mmol/L (peut ↘ rapidement) - Hypercalcémie (peut être abaissée par la PA) - Médicament : azathioprine, furosémide, cycline, oestrogène, acide valproïque, antirétroviraux... - Post-traumatisme fermé : écrasement de l'isthme pancréatique sur l'axe rachidien		- Auto-immune : à IgG4, MICI - Viral : VIH, CMV, oreillon, VHB, entérovirus - Bactérie : légionelle, BK, leptospirose, mycoplasme - Parasite : ascaridiose, hydatidose - Génétique : mucoviscidose, héréditaire - Canalaire : pancreas divisum - Idiopathique : 10% des cas		
TTT	Pancréatite aiguë bénigne	→ Hospitalisation en unité simple - Mise à jeun stricte et réalimentation orale classique après disparition des douleurs (≈ 5 à 10 jours) - Rééquilibration hydro-électrique rapide (5-10 ml/kg/h) + antalgique adapté (niveau 1 à 3) - SNG avec aspiration en cas de vomissements importants et incoercibles (exceptionnel) - Surveillance quotidienne : vérifier l'absence d'évolution vers une forme sévère				
	Pancréatite aiguë sévère	→ Hospitalisation en USC si risque d'évolution sévère : terrain, CRP > 150, SIRS persistant, Balthazar ≥ 4 → Hospitalisation en réanimation si défaillance viscérale - Mise à jeun stricte et nutrition entérale par sonde naso-gastrique ou -jéjunale en continu bas débit - TTT symptomatique : rééquilibration hydro-électrique (abondante) + antalgique adapté (niveau 1 à 3) - PEC classique des défaillances viscérales (aucun traitement spécifique pour la pancréatite aiguë) - Surveillance pluriquotidienne : clinique, créat, SpO ₂ , NFS 1/j, CRP 2/sem → TDM si aggravation → Aucune indication d'antibiothérapie préventive en l'absence de preuve d'infection				
	Traitement étiologique	Alcoolique	- Recherche des complications associées et PEC spécialisée			
		Biliaire	- Pancréatite bénigne : cholécystectomie rapide avant réalimentation avec exploration pré-opératoire (écho-endoscopie ou bili-IRM) ou per-opératoire de la voie biliaire principale - Angiocholite associée : sphinctérotomie + extraction endoscopique en urgence			